1. El Problema Actual

La Teletón debe planificar cómo se distribuyen las horas de más de 600 profesionales (médicos, kinesiólogos, psicólogos, etc.) en todos los institutos del país para establecer metas de atención. Actualmente, este proceso presenta graves deficiencias:

Fragilidad y trabajo manual: Todo depende de un único archivo Excel alimentado copiando y pegando datos desde los sistemas BUK (Recursos Humanos) y SIC (Sistema de Información Clínica).

Falta de trazabilidad y versionado: Los cambios en las jornadas, asignaciones o dotación se marcan manualmente (con colores o notas) y las versiones se guardan como copias del archivo, sin registro de quién autorizó las modificaciones.

Falta de visibilidad: Las reglas y porcentajes están ocultos en tablas de parámetros, y las jefaturas no tienen una vista simple o actualizada de la planificación de sus equipos.

Cosas importantes que debería tener nuestro MVP (producto mínimo viable)

- **recibir los reportes de BUK (RR.HH.) y SIC (clínico) sin copiar y pegar;**
- aplicar reglas editables sin tocar código;
- calcular, por profesional y por mes, las horas directas, indirectas, no asistenciales y disponibles, y la meta de atenciones.

¿cómo lograr que las metas se recalculen solas cuando cambian las horas, el cargo, las asignaciones o la dotación durante el año?

Las horas contratadas se reparten cada mes en tres bloques: **directa** (con pacientes, individual o grupal), **indirecta** (registros, informes, preparación) y **no asistencial o NAS** (coordinación, capacitación, docencia, investigación, comités, asignaciones especiales).

- BUK aporta la dotación:

SIC las atenciones realizadas por profesional y mes, para contrastar plan y ejecución. En 2026 la jornada baja de 44 a 42 h desde mayo, así que hay dos períodos: enero–abril y mayo–diciembre.

El cálculo, en el orden del documento:

1. **Horas contratadas por mes**, de BUK según la vigencia del contrato. Se calcula el promedio ponderado anual de horas semanales y se marca si hubo aumento o disminución de jornada.
2. **Tramo de jornada** según ese promedio: 40 h o más, entre 22 y 40, o menos de 22.
3. **Distribución por cargo**: con el cargo homologado y el tramo, la tabla de parámetros da % directo, % indirecto y % NAS.
4. **Asignaciones especiales**: se descuentan horas semanales fijas por rol (Líder de equipo 2 h, Tutor docente 1 h, Comité paritario 0,5 h, Reunión sindical 0,25 h, etc.). Máximo 2 para quien tiene más de 30 h semanales; algunas requieren autorización de la dirección nacional; el catálogo puede cambiar por necesidad institucional.

5. **Horas disponibles para atención**, repartidas proporcionalmente entre directa e indirecta.
6. **Conversión a atenciones** con los minutos estándar del cargo (directa 30, 40, 45 o 60 min; indirecta 30 min), redondeando hacia abajo. Educación, Asistente Social, Arte, Deporte y Unidad Laboral aplican además un % de atención grupal y un número de pacientes por grupo, distintos para Santiago/Concepción y el resto, o como defina la DMN (Dirección Médica Nacional).
7. **Proyección anual**: se cruza con días hábiles, feriados (incluidos los regionales) y vacaciones de cada mes.
8. **Meta de gestión**: piso mínimo equivalente a un % de la proyección anual, hoy 90 %..

Casos especiales que el MVP debe soportar:

- **Multi-instituto:** horas distintas por mes en dos o más institutos (hoja Excepciones).
- **Reemplazos y plazo fijo:** con vínculo al titular y fechas de vigencia.
- **Vacantes y cargos nuevos:** cupos sin persona que se planifican o se excluyen (conviene hacerlo configurable).
- **Licencias extensas:** marcan meses sin atención.
- **Cambio legal de jornada:** ***44 h hasta abril, 42 h desde mayo. IMPORTANTE***
- **Cambios** en asignaciones, beneficios y contractuales (cargo, jornada, IT, vigencia).
- **Zonas geográficas:** afectan vacaciones y días hábiles (en el documento entregado del caso, nombra: Arica y Ñuble por sus feriados regionales, y Aysén por sus vacaciones).

Qué debe mostrar el dashboard

- **Meta de Gestión Asistencial** = atenciones planificadas × 90 %.
- **% FOJA** (Factor de Ocupación de Jornada Asistencial) = horas mensuales disponibles para atención directa ÷ horas mensuales contratadas.

(Fijarse en tabla entregada)

- **Horas semanales:**
- en total:
- directas:
- indirectas :
- NAS:

- **No aparece el % FOJA, aunque el texto lo pide. (hay que agregarlo)**

Obligatorio

Blue Prism en el centro, con aporte visible

Datos sin copiar y pegar; errores del reporte detectados e informados

Reglas parametrizables sin tocar código

Cálculo correcto

Cambios durante el año

Visibilidad

Deseable (suma puntos):

- trazabilidad y versiones;
- plan vs realizado en SIC con alertas de desviación;
- multi-instituto, reemplazos y vacantes;
- aprobación de asignaciones que requieren autorización;
- simulación del impacto de un cambio de parámetro antes de aplicarlo;
- distribución automática de reportes a las jefaturas.

Para el cálculo:

1. Si las asignaciones especiales se descuentan además del % NAS del cargo o ya están dentro de él. El contexto define NAS como incluyendo las asignaciones, pero el cálculo las descuenta aparte. Es probablemente el punto más delicado.
2. Los pesos del promedio ponderado (meses o días de vigencia) y si 22 y 40 h son límites inclusivos. Si el tramo sale del promedio anual, un cambio en julio podría alterar retroactivamente enero–junio, pero el requisito dice que el plan se ajusta <desde la fecha en que rigen>. Hay que definir qué se congela.
3. La fórmula exacta de la atención grupal y de la proyección anual, y en qué paso se redondea hacia abajo.
4. **Si el cambio 44 → 42 h ya viene reflejado en BUK o lo aplica la solución como regla.**

- El kit no lista ningún archivo de SIC, **aunque su ingesta es obligatoria.**
-Cuáles son los «casos de prueba», y cuándo llega el reporte BUK de la demo (si es distinto al del kit).
-Multi-instituto, reemplazos y vacantes figuran como <debe soportar> y como <deseable>. **Falta saber cuál es el mínimo**.

- cómo nos podemos repartir los 5 min de demo y los 3 min de pitch, y qué apoyo habrá con Blue Prism.

Guion de demo de 5 minutos:

1. Estado inicial en el dashboard.
2. Archivo BUK con errores y el informe que genera.
3. Archivo con cambios (alta, baja, cambio de jornada con fecha) y el bot detectando el delta.
4. Recálculo desde la fecha de vigencia, con comparación antes/después en un instituto y un profesional.

-Anotar desde el inicio dónde se usa la IA, porque se debe declarar.

2. **Requisitos Técnicos y Funcionales**

El MVP debe resolver la ineficiencia actual cumpliendo con reglas de negocio específicas y restricciones técnicas:

Blue Prism Obligatorio: Es el único requisito tecnológico estricto; el bot debe ser el núcleo de la solución para automatizar etapas del proceso, y su aporte debe ser evidente en la demostración. Las bases de datos y lenguajes adicionales son de libre elección.

Automatización de Datos: **La solución debe procesar automáticamente los reportes simulados de BUK y SIC sin intervención humana, detectando errores y cambios en la dotación (altas, bajas, cambios de jornada).**

Parametrización: Las reglas de negocio (porcentajes de atención directa/indirecta, minutos estándar por atención, asignaciones especiales, días hábiles y feriados regionales) deben ser modificables sin alterar el código.

Gestión de Excepciones: El sistema debe soportar profesionales que trabajan en múltiples institutos, reemplazos, licencias médicas y, críticamente, el cambio legal de jornada laboral de 44 a 42 horas que entra en vigencia en mayo de 2026.

3. Entregables y KPIs Esperados

El equipo de planificación central será el usuario final de esta herramienta. Se espera que los equipos entreguen:

Dashboard Interactivo: Una vista consolidada a nivel nacional con capacidad de filtrar por instituto, tipo de atención, cargo o mes.

Indicadores Clave:

Meta de Gestión Asistencial: Calculado como el 90% de la sumatoria de atenciones resultantes planificadas.

% FOJA (Factor de Ocupación de Jornada Asistencial) = horas mensuales disponibles para atención directa ÷ horas mensuales contratadas.

4. Evaluación y Estrategia

La competencia contempla una ronda clasificatoria y una final mediante un "Pitch". La presentación no debe durar más de 3 minutos e incluir una lámina de arquitectura, seguida de una demostración en vivo de 5 minutos del MVP funcionando.

Rúbrica de Evaluación: El jurado medirá la definición del problema, la pertinencia de la solución, la innovación, la viabilidad técnica y el impacto esperado. Un punto crucial a considerar es la accesibilidad e inclusión, premiando diseños pensados para personas con discapacidad (ej. lectura fácil, compatibilidad con lectores de pantalla).

Estrategia de Desarrollo: Como recomendación principal, los equipos deben analizar qué tareas son puramente repetitivas (ideales para el bot, como leer, validar y comparar reportes de BUK/SIC) y cuáles requieren criterio humano o parametrización (ideales para una interfaz de aplicación donde se aprueben y visualicen los datos). Se trabajará exclusivamente con datos ficticios para cumplir con la normativa de protección de datos personales.

Contraste y Color (Discapacidad Visual y Daltonismo):No hay que usar solo un color. Si un profesional tiene un error en sus horas, no basta con poner la celda en rojo; hay que agregar un texto que diga "Error" o un ícono de alerta. Mantener un alto contraste: letras muy oscuras sobre fondos muy claros.

Textos Descriptivos para Lectores de Pantalla **(Ceguera total o parcial):** Los botones no pueden ser solo íconos. Si hay un botón con forma de lápiz para editar, hay que agregarle una etiqueta de código (como aria-label) que un lector de pantalla pueda interpretar como "Editar horas de este profesional".

Navegación por Teclado **(Discapacidad Motora)**: Exige que el dashboard pueda navegarse de principio a fin usando únicamente la tecla "Tab" y el botón "Enter", sin tocar el mouse. Esto es vital para personas que usan dispositivos adaptativos.

Tipografía de Lectura Fácil **(Dislexia y Neurodivergencia)**: Usar tipografías sin adornos, como Arial, Roboto o Verdana. El tamaño del texto base no debe ser menor a 16px, y los párrafos no deben estar justificados (alineados solo a la izquierda) para evitar los "ríos de espacio" en blanco que dificultan la lectura.

—----------

En lugar de ver un Excel gigante y enredado con 600 profesionales, ellos verán una interfaz limpia que debe incluir:

Filtros en la parte de arriba: Botones o menús desplegables para elegir el mes, el instituto (ej. Arica, Santiago, Aysén) o el tipo de profesional.

Tarjetas con los "KPIs" (Indicadores Clave): Números grandes que destaquen el % FOJA y la Meta de Gestión Asistencial.

Tablas resumen: Como la que sale en el documento, mostrando cuántas horas directas, indirectas y NAS tiene cada equipo.

% FOJA (Factor de Ocupación de Jornada Asistencial): Es el indicador de desempeño que mide qué porcentaje del tiempo total por el que se contrató a un profesional se dedica realmente a atender pacientes. Su fórmula es: Horas mensuales disponibles para atención directa / Horas mensuales contratadas.

NAS (Horas No Asistenciales): Es el tiempo de trabajo en el que el profesional no está atendiendo pacientes directamente ni haciendo informes. Corresponde a las horas dedicadas a tareas extra como coordinación, capacitación, docencia, investigación, comités o asignaciones especiales (como ser líder de equipo o estar en el sindicato).

BUK: Es el sistema o plataforma de Recursos Humanos (RR.HH.). En el desafío, este sistema entrega la información administrativa de los trabajadores (la "dotación"): instituto, cargo, tipo de contrato, horas semanales, reemplazos, licencias y si hay vacantes.

SIC (Sistema de Información Clínica): Es la plataforma médica donde se registran los pacientes. En el contexto del desafío, el SIC reporta cuántas atenciones reales hizo un profesional en un mes, lo que permite comparar la meta que se había planificado con lo que el profesional ejecutó en la realidad.